

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario STOP-Bang — Cribado de Riesgo de Apnea Obstructiva del Sueño (STOP-Bang)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	STOP-Bang
Nombre completo	STOP-Bang Questionnaire — Cuestionario de cribado de riesgo de Apnea Obstructiva del Sueño
Versión / edición	Versión español (EE.UU.), 21MAY2015 FINAL, publicada en el sitio oficial del titular.
Idioma	Español (variante US-spa; existen otras variantes en español en el mismo sitio oficial, no verificadas individualmente).
Autores	Chung F et al.; propiedad de University Health Network (Toronto, Canadá).
Año	Cuestionario original 2008 (Chung et al., Anesthesiology); actualización de criterios de puntuación 2012-2014; versión de traducción fechada 21MAY2015.
Tiempo estimado	no verificado

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Sueño; apnea obstructiva del sueño; cribado prequirúrgico; medicina conductual.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: riesgo de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), a partir de 8 factores clínicos y antropométricos (ronquidos, cansancio diurno,

apneas observadas, hipertensión, IMC, edad, circunferencia del cuello, sexo).

Finalidad: cribado rápido de riesgo de AOS (bajo/intermedio/alto) en población general o prequirúrgica, para orientar la derivación a estudio de sueño (polisomnografía) confirmatorio.

Usos apropiados:

- Cribado de riesgo de apnea obstructiva del sueño en atención primaria, medicina del sueño o evaluación prequirúrgica.
- Apoyo a la decisión de derivar a estudio de sueño confirmatorio (polisomnografía u otro).
- Complemento a otros instrumentos de sueño de este acervo (PSQI, ISI, ESS) dentro de una evaluación multimétodo de medicina conductual del sueño.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico de Apnea Obstructiva del Sueño: es un instrumento de cribado de riesgo, no una prueba diagnóstica; el diagnóstico requiere polisomnografía u otro estudio de sueño formal.
- Uso como única base para decisiones médicas o quirúrgicas de alto impacto sin confirmación diagnóstica.
- Sustituto de evaluación médica del sueño por especialista.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos, población general o en contexto prequirúrgico.
Contexto de aplicación	Atención primaria, medicina del sueño, anestesiología/evaluación prequirúrgica.
Informante	Autoinforme (algunas preguntas, como los episodios de apnea observados, pueden requerir información de terceros — p. ej. pareja de cama).
Modalidad de administración	Papel y lápiz o formato electrónico; individual; muy breve.

5. Estructura y administración

Número de ítems	8
Periodo temporal de referencia	no verificado
Formato de respuesta	Dicótoma (Sí / No)
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes

	consultadas (estimación editorial: 2-3 minutos, dada su brevedad y formato dicotómico).
--	---

6. Dimensiones y puntuaciones

No tiene subescalas: es una suma directa de respuestas afirmativas a los 8 ítems (STOP: 4 ítems clínicos + Bang: 4 ítems antropométricos/demográficos), con reglas adicionales de estratificación de riesgo alto basadas en combinaciones específicas de las primeras 4 preguntas (STOP) con sexo, IMC o circunferencia del cuello.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Se cuenta el número de respuestas 'Sí' entre las 8 preguntas (rango 0-8).
Ítems invertidos	No aplica; todos los ítems puntúan en el mismo sentido (Sí = 1 punto de riesgo).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	Bajo riesgo: 0-2 síes. Riesgo intermedio: 3-4 síes. Alto riesgo: 5-8 síes; o bien 2 o más síes en las primeras 4 preguntas (STOP) combinado con sexo masculino, o con IMC $>35 \text{ kg/m}^2$, o con circunferencia de cuello $\geq 43 \text{ cm}$ (hombres) / $\geq 41 \text{ cm}$ (mujeres). Fuente: texto del propio protocolo (criterios actualizados de Chung F et al., 2008-2014).

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Existe adaptación transcultural y validación específica al español publicada en Revista Española de Anestesiología y Reanimación (adaptación y validación en 100 pacientes consecutivos, señalada como herramienta fiable y válida para estratificación de riesgo quirúrgico) y en Gaceta Sanitaria (utilidad diagnóstica en atención primaria); no se accedió al texto completo de estos estudios de validación española durante esta sesión (solo a sus resúmenes/referencias) — no verificado en detalle, consultar las fuentes primarias antes de citar coeficientes psicométricos exactos.

9. Adaptación cultural y norma local

Existen validaciones transculturales al español publicadas en España (perioperatorio) y estudios de utilidad diagnóstica en atención primaria en español (ver evidencia); no se verificó en esta sesión la existencia de normas diferenciadas para Latinoamérica.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Es un instrumento de CRIBADO de riesgo, no una prueba diagnóstica: un puntaje alto requiere confirmación mediante estudio de sueño (polisomnografía).
- El propio documento del titular reserva el copyright ('Propiedad de University Health Network') y remite a www.stopbang.ca para condiciones de uso ampliado.
- No sustituye evaluación médica especializada del sueño.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención (p. ej. decisiones quirúrgicas de alto riesgo).
- Las reglas de estratificación de riesgo alto son más complejas que un simple punto de corte por suma; deben aplicarse tal como se describen en el protocolo, no simplificarse.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El documento está marcado 'Propiedad de University Health Network' (Toronto); es ampliamente utilizado en investigación y práctica clínica internacional citando la fuente (Chung F et al., *Anesthesiology* 2008; Br J Anaesth 2012; J Clin Sleep Med 2014). No se identificó una licencia de dominio público explícita; se recomienda uso académico/asistencial no comercial con cita de fuente y consulta a www.stopbang.ca para condiciones de uso extendido. El Protocolo.pdf de este acervo es una reconstrucción textual verificada (no el binario original del titular, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar).

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Chung F, Yegneswaran B, Liao P, et al. (2008). STOP questionnaire: a tool to screen patients for obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*, 108, 812-821.

Chung F, Subramanyam R, Liao P, Sasaki E, Shapiro C, Sun Y (2012). High STOP-Bang score indicates a high probability of obstructive sleep apnoea. *Br J Anaesth*, 108, 768-775.

University Health Network (2015). STOP-BANG (US-spa) 21MAY2015 FINAL
— Cuestionario STOP-Bang actualizado.
<http://www.stopbang.ca/translation/pdf/spanus.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 8 ítems completos + criterios de calificación). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0